Caso Clínico 3

1. Información personal:

- Nombre: Araos Gutierrez Yeferson
- Edad: 1 año con 10 meses.
- Dirección: No especifica su dirección.
- Fecha de nacimiento: 27/09/2023, Lima
- Médico (s) y especialistas: Fue visto por un Neurocirujano, un especialista en Radiología y en Terapia Física.
- Fuente de referencia y motivo de la referencia: El motivo de consulta fue el de que el bebe padecía una posible Escoliosis .Cuando tenía 1 año 6 meses el 22 de abril del 2025 fue referido del Hospital María Auxiliadora por escoliosis por un neurocirujano y fue indicado de tener un examen de RMN para evaluación de disrafismo.
- Regímenes de tratamiento médico o terapéutico existentes y sus objetivos: Se tiene como objetivo tratar a un de 1 años con 10 meses con escoliosis doble curva dorsal izquierda moderada, lumbar derecha moderada congénita. ante la falta de cooperación que presenta y los frecuentes cambios de corsé por su constante crecimiento.

2. Financiamiento:

El paciente fue atendido primero en el Hospital María Auxiliadora donde recibió su primera consulta y luego fue derivado al Instituto nacional de salud del niño (INSN). Por otro lado, se indica que el material de su vivienda es de únicamente triplay y que solo cuenta con luz. Por lo que se puede observar que Yeferson vive en un hogar que no cumple con todos los servicios básicos, en una casa que no es de material noble (cemento, ladrillo) y con presupuesto de poder atenderse en el Hospital María Auxiliadora. Por lo que depende del financiamiento que le pueda brindar el INSN para su tratamiento y de ayuda familiar externa.

3. Diagnósticos e historial médico:

El motivo de consulta inicial fue el de una posible escoliosis congénita.

- **Primera consulta: 26/04/2025**

Se le notó alteración de postura en la columna, fue atendido primero en el Hospital María Auxiliadora y después derivado al INSN, no es candidato para cirugía de momento.

Examen Físico: Talla de 75 cm y peso de 11kg. Presenta una marcha normal y con ángulo de progresión normal, en su columna vertebral presenta un descenso de hombro derecho, descenso de escápula derecha y Maniobra de Adams (+).

Diagnóstico: Escoliosis dorsolumbar congénita dorsal izquierda moderada Q76.3.

Plan de trabajo: Rayos X de columna dorsal y lumbosacra, y mensurador de miembros inferiores (MMII) y pelvis.

- **Resultados rayos X (Rx): 26/04/2025**

Rx PA (Posterior): lateralización dorsal izquierda, ángulo Cobb 33.8. Apex D9, RV 2. Lateralización lumbar derecha, ángulo de Cobb 25. Apex L2. RV 2 Risser 0.
Rx Perfil: Ángulo dorsal 28, ángulo lumbosacro 45,5. Ángulo de Ferguson 40. LW: N, 5 mm detrás del sacro.
Mensurador de MMII: normal

- **Segunda consulta (control): 05/05/2025**

Se le indicó obtener un Corsé tipo Baby Boston, 4 sesiones de terapia física y sesiones de Psicología.

- **Evaluación de desarrollo psicomotor: (18/07/2025)**

Control cefálico	No recuerda
Control de tronco	7 meses
Gatea	10 meses
Bipedestación	1 año
Marcha	1 año 6 meses
Comprende órdenes	1 año 6 meses
Primeras palabras	1 año 6 meses
Control de esfínteres	Continuar con prueba de pañal

- **Terapia física: 09/06/2025 – 18/06/2025**

Al principio fue evaluado con dificultad porque lloraba mucho. Fue notado con alineamiento alterado, inclinación de tronco, caído peso en lado izquierdo. Al finalizar su terapia física se le tuvo que enseñar a su madre los ejercicios por falta de cooperación.

- **Tercera consulta (control): 11/08/2025**

Tiene 1 año 10 meses, pesa 13 kg y mide 85 cm. Aun no le toman medidas de corsé rígido, practica sus ejercicios en casa, no va a neurocirugía y aún tiene pendiente cita de control en Desarrollo psicomotor. Aún no es muy colaborativo (llora mucho).

Diagnóstico: Escoliosis doble curva dorsal izquierda moderada, lumbar derecha moderada congénita.

Plan de trabajo: Corsé semirrígido dorsolumbar con hiperextensión, 4 sesiones individuales de terapia física, seguimiento de corsé Baby Boston.

Próxima radiografía en octubre 2025, pedir referencia a Neurocirugía y sacar cita en DPM.

4. Estado psicosocial

- **Interacción social, comunicación y cognición:** El niño presenta retraso leve del desarrollo del lenguaje (primeras palabras a los 18 meses, vocabulario limitado a

palabras simples). La interacción social es adecuada para la edad, aunque muestra irritabilidad y temor durante las evaluaciones médicas, lo que dificulta la colaboración.

- **Conciencia de seguridad y juicio:** Aún en etapa preescolar, depende del entorno familiar para la seguridad. No hay conciencia de riesgos ni juicio propio acorde a su edad.

- **Comportamientos y personalidad:** Niño temeroso, poco colaborador en consultas y terapias, tendencia a llorar con facilidad.

- **Motivación y aprendizaje:** Presenta disposición limitada a seguir indicaciones debido a la edad e irritabilidad, pero responde mejor cuando las pautas son enseñadas a la madre, quien constituye su principal apoyo.

- **Sistema de apoyo:** Cuenta con la presencia y acompañamiento de su madre; familia nuclear estable con dos hermanos sanos.

- **Actitud y tolerancia a la tecnología:** Tolerancia reducida al corsé (debido a la incomodidad y edad), lo que puede afectar la adherencia.

- **Situación de vida y entorno:** Vivienda de material básico (triplay), acceso a electricidad, recursos limitados.

- **Escuela, vocación, recreación:** Aún no escolarizado; actividades recreativas no descritas, aunque probablemente limitadas por la vigilancia materna.

- **Rutina diaria y actividades:** Actividades acordes a su edad, con juego libre y exploración; equipo utilizado en proceso de adaptación (corsé tipo Baby Boston). Posición preferida: bipedestación y marcha independiente.

5. Estado neuromuscular y musculoesquelético

- **Estatura y peso:** Talla 85 cm, peso 13 kg (dentro de parámetros, aunque talla algo baja para la edad).

- **Articulaciones (ROM):** Movilidad conservada en caderas y extremidades; tolerancia a fuerzas correctivas aún en prueba (corsé semirrígido).

- **Músculos:** Tono y trofismo conservados; no hay espasticidad ni debilidad documentada.

- **Influencias neurológicas:** Antecedentes de disrafismo sacro; por ahora sin déficits motores ni sensitivos evidentes, aunque se mantiene en riesgo. Reflejos primitivos no descritos.

- **Postura:** Presenta escoliosis dorsolumbar con doble curva; descenso de hombro y escápula derecha; control postural funcional, aunque con desequilibrio visible (inclinación de tronco, base amplia de sustentación).

- **Control motor:** Marcha independiente, amplia base de sustentación, coordinación aceptable para la edad; sin movimientos anormales.

- **Patrones de movimiento:** Voluntarios y espontáneos acordes a su edad, aunque con compensaciones posturales.

- **Sedestación y alineación esquelética:** Asimetría espinal marcada, sin evidencia de deformidad pélvica significativa; desviaciones flexibles en evaluación actual.

- **Potencial y tolerancia para corrección:** Buen potencial de corrección con uso temprano de corsé, aunque la tolerancia está limitada por la irritabilidad y el crecimiento constante.

6. Afección de la piel:

● Afección de la piel, cicatrices, textura de los tejidos blandos, edema, color, palidez:

En la información proporcionada del caso clínico no se registran afecciones visibles o documentadas en la piel. No se mencionan cicatrices previas, alteraciones en la textura de los tejidos blandos, ni signos como edema, palidez o cambios anormales en la coloración cutánea.

Tampoco se indica la presencia de lesiones dermatológicas asociadas al uso de dispositivos ortésicos o al desarrollo psicomotor del niño.

A pesar de que el paciente presenta una condición ortopédica (escoliosis congénita) que implica el uso de corsé, no se han reportado alteraciones cutáneas relacionadas hasta el momento, aunque esto debe vigilarse de forma continua dada la sensibilidad de la piel en la infancia.

● Antecedentes o presencia de úlceras por presión, ubicación, causas desencadenantes, circunstancias circundantes, tratamiento, riesgos:

El caso clínico no reporta antecedentes ni presencia actual de úlceras por presión. Tampoco se describen localizaciones específicas, desencadenantes o tratamientos relacionados con este tipo de lesiones.

No obstante, se identifican riesgos potenciales, ya que el paciente está en proceso de adaptación a un corsé ortopédico, lo que conlleva posibilidad de presión prolongada sobre puntos específicos del cuerpo, especialmente si el niño no colabora adecuadamente o no tolera bien el dispositivo.

La irritabilidad y la baja colaboración del paciente pueden dificultar el ajuste correcto y la supervisión constante del uso del corsé, lo que aumenta el riesgo de desarrollar lesiones por presión si no se controla cuidadosamente la integridad de la piel durante su uso.

7. Parte 1: Función sensorial:

- **Visión: visión funcional, agudeza, percepción visual:**

En la información clínica no se hace referencia a alteraciones visuales ni se reportan antecedentes de problemas oftalmológicos. No se documenta evaluación específica de agudeza visual ni de percepción visual, pero tampoco hay signos clínicos que sugieran alguna disfunción evidente. Dado que el paciente sigue órdenes simples y demuestra cierta comprensión verbal, puede inferirse que la visión funcional está preservada, aunque sería recomendable una valoración formal si se presentan dudas o dificultades visuales a futuro, especialmente por el uso de corsé y su impacto potencial en el campo visual periférico si no se ajusta correctamente.

- **Audición:**

No se reportan alteraciones auditivas en el caso ni antecedentes de hipoacusia. El niño comprende órdenes a los 1 año y 6 meses, lo cual sugiere una audición funcional adecuada para su edad. Esta capacidad de comprensión indica que los canales auditivos están operativos, al menos en lo que respecta al lenguaje receptivo. No obstante, no se menciona ninguna evaluación audiológica formal, por lo que no puede descartarse por completo una hipoacusia leve o específica sin un estudio más detallado, especialmente si en algún momento se detectan retrasos en la comunicación verbal.

- **Percepción sensorial: tacto, propiocepción, sentido kinestésico:**

En cuanto a la percepción sensorial, se observa que el niño presenta una reacción negativa al contacto físico durante las sesiones de terapia, llora intensamente y no se deja tocar, lo cual podría estar indicando una **hipersensibilidad táctil** o dificultades en la **integración sensorial**. Esta respuesta podría estar afectando tanto su desarrollo motor como su capacidad para participar en intervenciones terapéuticas. Además, presenta alteraciones en el alineamiento corporal y distribución del peso, lo que sugiere una posible disfunción en la **propiocepción** o en el **sentido kinestésico**, aspectos que deben ser abordados con un enfoque sensoriomotor. Por esta razón, se ha indicado el manejo en el área de Desarrollo Psicomotor (DPM) específicamente para trabajar el componente sensorial.

7. Parte 2: Habla, lenguaje y comunicación:

- **Capacidad de lenguaje expresivo y receptivo:**

El paciente comprende órdenes desde los 1 año y 6 meses, lo que indica que su lenguaje receptivo está desarrollado acorde a su edad. Además, se registran las primeras palabras también alrededor de esta edad, mostrando que tiene un nivel inicial de lenguaje expresivo.

Sin embargo, no hay detalles sobre la variedad o complejidad de su vocabulario, ni sobre posibles retrasos o dificultades específicas en la comunicación, por lo que se asume un desarrollo lingüístico básico en proceso.

- **Habla, articulación:**

No se reportan dificultades específicas en la articulación del habla, aunque el caso no detalla evaluaciones formales en esta área. Dado que el niño está en una etapa temprana del desarrollo del lenguaje, es común que la articulación aún se esté consolidando.

Tampoco se menciona la presencia de trastornos del habla ni problemas motores orales que afectan la producción verbal.

- **Nivel cognitivo, capacidad de aprendizaje, capacidad de atención, estado académico/educativo:**

El niño muestra capacidad para comprender órdenes simples, lo que sugiere un nivel cognitivo acorde a su desarrollo psicomotor. No hay información sobre evaluaciones cognitivas formales ni sobre su estado educativo, ya que probablemente aún no asiste a un centro escolar debido a su corta edad (1 año 10 meses). Se observa que su capacidad de atención puede estar limitada por su irritabilidad y poca colaboración, aspectos que podrían afectar su aprendizaje y participación en terapias.

- **Uso y experiencia con dispositivos generadores de habla:**

No se menciona en el caso el uso de dispositivos generadores de habla, ni experiencias previas con tecnologías asistivas para la comunicación. Esto probablemente se deba a que el paciente está en una etapa inicial de desarrollo del lenguaje y no ha requerido apoyo tecnológico para comunicarse.

8. Desempeño funcional, de habilidades y tareas:

Actualmente ya es capaz de seguir órdenes, puede dar marcha de manera normal y puede seguir practicando los ejercicios de la terapia física con su madre. Sin embargo, aún tiene 1 año 10 meses por lo que aún es dependiente de sus padres, además no es muy colaborativo con las consultas, controles y terapias físicas con los especialistas.

9. Movilidad personal:

A pesar de que puede caminar por su cuenta, aún tiene 1 año 10 meses y necesita la guía de sus padres para su propia seguridad.

10. Transporte comunitario:

- **Transporte intrahospitalario**

  Dentro de los centros de salud (INSN, María Auxiliadora), el traslado es realizado por camilleros o en brazos de la madre, considerando que es un niño pequeño y aún no se maneja de forma autónoma para largas distancias en hospital.

- **Transporte interhospitalario y ambulatorio**

Traslado en **ambulancia** al inicio (referencia del Hospital María Auxiliadora al INSN por escoliosis congénita).
Traslados ambulatorios (probablemente en transporte público o particular) acompañados

por la madre para controles periódicos y terapias.

- **Transporte terapéutico especializado**

Para los procedimientos más complejos (ejemplo: molde de yeso para corsé en el INR o resonancia magnética), se puede utilizar **ambulancia programada** o transporte sanitario adaptado, dependiendo de la condición clínica del paciente.

11. Entornos:

- **Familiar y domiciliario**

➔ Vive en una vivienda de triplay, con acceso únicamente a luz eléctrica.

➔ Entorno socioeconómico limitado, lo que influye en las condiciones de salud, el seguimiento de controles y la adherencia a tratamientos (uso del corsé, terapias).

➔ La madre es la principal cuidadora, quien lo acompaña a todas las citas y terapias.

- **Entorno hospitalario y especializado**

➔ Ha tenido atenciones en **Hospital María Auxiliadora**, **Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN)** y en consultas de servicios especializados (Neurocirugía, Posturales, Terapia Física, Psicología, Servicio Social, Desarrollo Psicomotor).

➔ En estos espacios se aplican diagnósticos, exámenes (Rx, RMN), toma de medidas para corsé y sesiones terapéuticas.

- **Entorno terapéutico y social**

➔ Sesiones de **Terapia Física** y seguimiento psicológico/social.

➔ Participación en programas de desarrollo psicomotor para reforzar el área sensorial y motriz.

➔ Se menciona que el niño presenta dificultad para colaborar (llanto, irritabilidad), lo cual condiciona la efectividad de la intervención.

➔ La madre es la principal cuidadora, quien lo acompaña a todas las citas y terapias.

12. Historial de equipos anteriores:

Qué funcionó, qué no, y por qué

- **Equipos/órtesis previos:**

  No hay constancia de un corsé rígido previamente entregado. En Posturales (05/05/2025) se indicó “Corsé tipo *Baby Boston*”, pero a la fecha de control

(11/08/2025) “aún no le toman medidas de corsé rígido”. Se planifica “corsé semirígido dorso lumbar con hiperextensión para probar tolerancia” (indicador de que el equipo definitivo todavía no se implementa).

- **Intervenciones que sí aportaron:**

  Educación a cuidadora y pautas de TF (09–18/06/2025): la madre aprendió ejercicios demostrativos; pese a la baja colaboración del niño, la transferencia de pautas al hogar es un facilitador clave para la futura adherencia al corsé y para el acondicionamiento sensorial.

- **Lo que no funcionó / barreras:**

  Baja tolerancia al manejo: “llora mucho, no se deja tocar”, “poco colaborador y muy temeroso” en varias evaluaciones → esto dificulta desde la toma de molde (yeso) hasta la adaptación a un TLSO. Se sugiere DPM por manejo sensorial.

Edad y tipo de escoliosis (congénita): la evidencia sugiere que el bracing es menos eficaz en curvas congénitas cortas y rígidas; puede ayudar a curvas secundarias/compensatorias, más que a la primaria estructural. Esto puede haber retrasado la decisión/implementación de un corsé rígido definitivo.

Gustos, disgustos y preocupaciones respecto al equipo

- **Cuidadora**: prioriza soluciones que no intensifiquen el llanto y que sean manejables en casa; preocupaciones por la tolerancia del niño al corsé (razón por la “prueba de tolerancia” con semirrígido).
- **Paciente:** perfil sensorial irritable; disgusto ante manipulaciones prolongadas o restrictivas (previsible rechazo inicial a un TLSO).

Tolerancia del cliente a la tecnología o al cambio

- **Tolerancia actual:** Baja. El equipo clínico plantea aclimatación progresiva (semirrígido de prueba) antes del corsé rígido definitivo. Estrategias de desensibilización y escalamiento de horas de uso se alinean con guías clínicas (incrementos graduales hasta el uso prescrito en ~5–10 días, según tolerancia).
- **Implicación terapéutica:** requiere entrenamiento al cuidador, seguimiento frecuente y manejo conjunto con DPM/psicología para modular reactividad sensorial, maximizando adherencia futura al corsé.

13. Equipo actual (Estado del arte):

Modelo, estilo, marca, número de serie

No cuenta aún con corsé rígido definitivo. Plan en curso: “corsé semirígido dorso lumbar con hiperextensión” como prueba de tolerancia; el corsé rígido definitivo (p. ej., estilo *Boston* pediátrico / TLSO) se fabricaría por molde de yeso en biomecánica del INR (no usan escáner). Marca y N° de serie: no consignados en la historia.

Características

- **Tipo:** TLSO semirrígido de hiperextensión (funcionalmente un armazón que aplica sistema de tres puntos para limitar flexión y controlar la curva dorso lumbar). En versión pediátrica, peso típico bajo (≈ 0.3–0.7 kg según talla/material) y altura hasta línea axilar; cierre por velcros para ajuste rápido. (Características biomecánicas del TLSO/Boston: sistema de almohadillas y tres puntos de presión; objetivo: contener/progresión)
- **Fabricación prevista (definitivo):** termoplástico rígido personalizado por yeso (INR), sin CAD/CAM/escáner, lo que demanda toma de molde con cooperación del paciente

Objetivos y justificación para elegir esta tecnología

1. Contener la progresión de curvas durante el crecimiento (ángulos de Cobb reportados: 33.8° torácica y 25° lumbar al 26/04/2025), buscando evitar/demorar cirugía mientras se reevalúan curvas y maduración.
2. En escoliosis congénita, el bracing no corrige curvas primarias rígidas, pero puede ayudar en curvas secundarias/compensatorias y proponer intervenciones en casos seleccionados o servir como “puente” mientras se optimiza tolerancia y manejo conductual/sensorial.
3. El semirrígido de hiperextensión como “test” minimiza el riesgo de rechazo al rígido definitivo y entrena tolerancia (enfoque consistente con protocolos de incremento progresivo de horas, seguimiento y ajustes frecuentes).

Vida útil restante prevista: antigüedad, estado, historial de reparaciones

- Estado: en etapa de indicación/ prueba; no hay historial de reparaciones.
- Vida útil estimada (pediátrica): por el rápido crecimiento (1–2 años de edad), un TLSO puede requerir reemplazo/ajustes cada 3–6 meses, con controles cada 3–6 meses para evaluar fit, altura/peso y marcas de presión.

Gustos, disgustos e inquietudes del cliente y del cuidador

- **Cuidador:** inquietud por “orina cargada” y estreñimiento (no directamente del corsé, pero relevantes para confort/uso prolongado); preocupación central: tolerancia del niño al corsé y al proceso de molde
- **Paciente:** hiperreactividad al contacto y limitación de cooperación; probable rechazo inicial a órtesis rígidas; se sugiere gradualidad y acompañamiento conductual/sensorial.

Eficacia funcional del equipo actual y uso correcto

Actualmente sin corsé rígido entregado, por lo que la eficacia funcional aún no se puede juzgar; la utilidad del semirrígido de prueba dependerá de adherencia horaria y calce adecuado (puntos críticos para que un TLSO tenga impacto).

Buenas prácticas de uso (cuando se entregue el TLSO):

- Escalamiento progresivo de horas hasta el régimen indicado
- Revisiones 3–6 meses para ajuste/cambio por crecimiento
- Entrenamiento a cuidadores para colocación, detección de puntos de presión, higiene de piel, y coordinación para ejercicios complementarios.

RESUMEN INFORMATIVO:

a) Usuario/Paciente

Yeferson es un niño de 1 año y 10 meses con diagnóstico de escoliosis congénita de doble curva (dorsal izquierda y lumbar derecha). Presenta habilidades funcionales acordes a su edad como la marcha independiente, comprensión de órdenes simples y primeras palabras desde los 18 meses. Sin embargo, tiene dificultades sensoriales (irritabilidad al contacto físico), bajo nivel de cooperación en sesiones médicas/terapéuticas y un desarrollo lingüístico aún limitado. Su nivel cognitivo y motricidad gruesa se mantienen dentro de rangos funcionales, aunque su postura muestra compensaciones evidentes (inclinación del tronco, base amplia de sustentación).

b) Actividad

El conjunto de actividades que Yeferson debe realizar incluye el uso progresivo de un corsé ortopédico (inicialmente semirrígido), la participación en sesiones de terapia física, seguimiento en desarrollo psicomotor y evaluación sensorial. Estas tareas están orientadas a mejorar su alineación postural, tolerancia al corsé y prevenir la progresión de la escoliosis. Además, en el entorno familiar se espera que continúe practicando los ejercicios físicos enseñados a la madre y que gradualmente desarrolle mayor tolerancia al contacto físico para facilitar intervenciones terapéuticas futuras.

c) Contexto

Yeferson vive en un entorno socioeconómico limitado, en una vivienda de triplay con acceso solo a luz eléctrica. Su madre es su principal cuidadora y lo acompaña a todas las citas médicas y terapias, siendo un factor clave en su atención. El paciente ha sido atendido en centros de salud públicos como el Hospital María Auxiliadora y el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), donde ha recibido atención especializada en neurocirugía, terapia física y desarrollo psicomotor. La escasa tolerancia al manejo clínico, su corta edad y las barreras económicas influyen en la continuidad y eficacia del tratamiento.

d) Tecnología

El principal dispositivo terapéutico indicado es un corsé toraco lumbosacro (TLSO) tipo Baby Boston. Actualmente se utiliza una versión semirrígida como prueba de tolerancia, debido a la baja colaboración del niño y la necesidad de moldear un corsé rígido personalizado con

yeso. El corsé busca contener la progresión de la escoliosis durante el crecimiento. Además, se aplican estrategias complementarias como el entrenamiento a la madre en ejercicios posturales y terapias sensoriales para facilitar la adherencia al tratamiento. El uso de este tipo de tecnología exige seguimiento frecuente y ajustes por el crecimiento del paciente.